

14 WINNICOTT. EL PAPEL DE LA MADRE REAL ILUSION, SOSTEN, OBJETO TRANSICIONAL PRESENTACION *

✓ Donald Winnicott nació en Inglaterra a fines del siglo pasado. Inició su carrera profesional como pediatra en el Paddington Green Children's Hospital de Londres en 1923, época en la cual, a través de una recomendación de Ernest Jones, empezó a psicoanalizarse con James Strachey. Ambas experiencias, el ejercicio de la pediatría y su análisis personal, marcaron de manera fundamental su labor posterior. ^{con}

✓ Muchos años después nuestro autor se refirió a sus comienzos con las siguientes palabras: "Por aquél entonces yo iniciaba mi carrera de pediatra consultor y podrán imaginarse la emoción que sentía al ver que en los innumerables casos que trataba en los hospitales los padres de los pacientes - personas por lo general no instruidas - confirmaban todas las teorías psicoanalíticas que empezaban a significar algo para mí a través de mi propio análisis" (1962, pág. 208).

✓ Como veremos más adelante, a la tutoría de Jones y Strachey se agregó la de Melanie Klein. Winnicott fue, verdaderamente, un estudioso privilegiado del psicoanálisis, ya que se formó a la sombra de tres de las más importantes figuras de su época. ^{Klein, Jones y Strachey}

✓ Su obra muestra la huella de las impresiones que tuvo a partir de su trabajo de pediatra. Winnicott es en efecto, un teórico del desarrollo temprano del ser humano. El lector notará a lo largo de las siguientes páginas cómo la observación de la conducta de los niños y sus madres influyó de manera decisiva en su enfoque psicoanalítico.

✓ A partir de su experiencia con niños pequeños, advirtió que buena parte de los problemas emocionales parecían encontrar su origen en etapas tempranas del desarrollo. Refiriéndose a esto, dijo:

“Corrían los años 20 y parecía que todo tuviese su origen en el complejo de Edipo... Ahora bien, los incontables casos que pasaban por mi consultorio demostraban que los niños aquejados de algún trastorno psiconeurótico, psicótico, psicosomático o antisocial, ya daban señales de padecer alguna anomalía de su desarrollo emocional durante la primera infancia, incluso cuando sólo eran unos bebés” (*ibid.*, págs. 208-209).

Es de destacar la coincidencia con la que dos analistas que aún no se conocían, Winnicott y Melanie Klein, enfatizaban la importancia que adquieren las etapas iniciales en el desarrollo emocional del individuo.

En 1936 publica su primer trabajo dedicado a analizar la relación entre los trastornos de la alimentación y los conflictos emocionales. En él describe que, lejos de lo que se suponía en esa época, el infante posee complejas fantasías y emociones. Según su punto de vista el mundo interior se construye a partir de los dos aspectos esenciales de la fantasía oral: el conservar y el eliminar. Quisiéramos destacar que para ese momento era bastante novedoso adjudicar a tales fantasías el origen del psiquismo humano. En esos años, el foco de atención estaba puesto en los mecanismos de defensa y la problemática edípica. Se pensaba que todo lo sucedido antes adquiría su pleno significado sólo después del pasaje por dicha etapa. Según el punto de vista de nuestro autor, opinión que compartía con Melanie Klein, el desarrollo emocional debía considerarse como una línea de progresión en que lo arcaico definía las características de lo por venir.

Tiempo después de la publicación de este trabajo, James Strachey le sugirió que se acercara a Melanie Klein. Así fue como Winnicott supervisó con ella entre los años 1940 y 1944.

Si bien esta experiencia acentuó definitivamente su interés por las relaciones de objeto tempranas, más tarde surgieron importantes diferencias teóricas que motivaron su distanciamiento de Melanie Klein. Probablemente el principal desacuerdo consistió en el papel que cada uno adjudicaba al medio ambiente en el desarrollo emocional del niño. Muy sintéticamente podríamos decir que mientras para Klein éste era un factor importante pero en el que no concentró su atención, para Winnicott fue transformándose en el elemento fundamental, al punto de considerar las fallas ambientales como la etiología principal de los distintos cuadros psicopatológicos.

Como en otros modelos teóricos, el peso etiológico otorgado al ambiente real dio origen en el pensamiento de Winnicott a propuestas terapéuticas dirigidas a brindar en el análisis un entorno

emocional favorable, para así posibilitar un pleno desarrollo.

El concepto teórico que mejor ejemplifica esta línea de pensamiento es el de sostenimiento o *holding*, término acuñado por Winnicott para describir una conducta emocional de la madre respecto a su hijo. En torno a los éxitos o fracasos del sostenimiento se sitúan los distintos grados de perturbación psíquica.

Otra idea, íntimamente vinculada con la anterior, es la de falso y verdadero *self*. Luego estudiaremos de qué manera Winnicott asocia las características ambientales con la representación que el sujeto logra de sí mismo y con el tipo de vínculo que establecerá en el futuro con las demás personas.

Como sucede con frecuencia en el pensamiento psicoanalítico, a las observaciones clínicas sigue un intento de sistematización de un modelo evolutivo. Nuestro autor no se mantuvo ajeno a esto. En efecto, Winnicott elaboró una teoría del desarrollo emocional. En ella trató de anclar los puntos de fijación de las perturbaciones psicológicas consideradas, por supuesto, desde su punto de vista del falso y verdadero *self*.

1. Importancia del medio ambiente en el desarrollo mental primitivo

El concepto de sostenimiento o *holding*

Si bien en un principio Winnicott otorgó mucha importancia a las fantasías inconscientes del bebé, al punto de considerar que éste era un artífice de su medio ambiente, poco a poco fue dejando de lado esta opinión en beneficio del punto de vista opuesto. En 1936 dijo, en relación con un niño de dieciocho meses: “Observen de qué manera este pequeño se crea para sí mismo un medio ambiente anormal” (pág. 72). Pero a medida que progresó en su pensamiento original, Winnicott acentuó cada vez más la influencia decisiva del ambiente en la determinación del psiquismo temprano.

Hacia 1960 escribió su trabajo quizá más completo sobre el papel de la madre en el desarrollo emocional del individuo. Su título es “La teoría de la relación paterno-filial”. En este artículo describe exhaustivamente lo que él entiende por sostenimiento y su importancia en el desarrollo afectivo temprano. Para Winnicott el niño nace indefenso. Es un ser desintegrado, que percibe de manera desorganizada los distintos estímulos que provienen del exterior. Además de estas características innatas, el bebé nace provisto de una tendencia

al desarrollo. La misma que Hartmann teorizó como "zona libre de conflictos del yo". Este "yo autónomo" abarca no sólo las funciones perceptuales, de gran importancia en los comienzos de la vida, sino también las funciones de motilidad y los instintos. La tarea de la madre es brindar un soporte adecuado para que las condiciones innatas logren un óptimo desarrollo.]

En el sostenimiento (*holding*) hay una función fisiológica e incluso física: [El sostenimiento protege contra la afrenta fisiológica; toma en cuenta la sensibilidad epidérmica de la criatura -tacto, temperatura, sensibilidad auditiva, sensibilidad visual, sensibilidad a las caídas (acción de la gravedad)- así como el hecho de que la criatura desconoce la existencia de todo lo que no sea ella misma; incluye toda la rutina de cuidados a lo largo del día y de la noche] que no es nunca la misma en dos criaturas distintas, ya que forma parte de ellas y no hay dos criaturas iguales; [sigue, asimismo, los cambios casi imperceptibles que día a día van teniendo lugar en el crecimiento y desarrollo de la criatura, cambios tanto físicos como psicológicos...]. El sostenimiento comprende en especial el hecho físico de sostener la criatura en brazos y que constituye una forma de amar. (1960a, pág. 56).

Esta protección y cuidado que debe proporcionar la madre a su hijo no tiene sólo implicancias fisiológicas destinadas a garantizar la supervivencia. En la medida que estos cuidados son provistos adecuadamente para lo cual, como indica Winnicott, es necesario sentir amor, el niño logrará integrar tanto los estímulos como la representación de sí mismo y de los demás y adquirir un yo sano. La madre funciona como un "yo auxiliar" hasta tanto el bebé logre desarrollar sus capacidades innatas de síntesis, integración, etc. El niño vive el sostenimiento exitoso como una "continuidad existencial". Sus fallas se traducen en una experiencia subjetiva de amenaza que obstaculiza el desarrollo normal.]

¿Qué es-lo que capacita a la madre para proporcionar estos cuidados iniciales?

Winnicott propone que durante los últimos meses del embarazo y las primeras semanas posteriores al parto se produce en la madre un estado psicológico especial, al que llamó "preocupación maternal primaria".

La madre adquiere, gracias a esta sensibilización, una particular capacidad para identificarse con las necesidades del bebé. Esta disposición especial alcanza su máxima intensidad inmediatamente después del parto y va disminuyendo poco a poco, a medida que la criatura crece.]

En síntesis, el sostenimiento realizado por la madre es el factor que decide el paso del estado de no integración, que caracteriza al recién nacido, al de posterior integración. Este vínculo físico y emocional entre la madre y el bebé sentará las bases para el desarrollo saludable de las capacidades innatas del individuo.]

¿Qué consecuencias tiene un sostenimiento deficiente? A este tema dedicaremos el siguiente apartado.

Adelantemos que cuando el "yo auxiliar" provisto por la madre resulta insuficiente, el niño puede recurrir a la construcción de un "yo auxiliar" falso, del que él mismo se hace cargo. Winnicott lo bautizó "falso self".

2. Self verdadero y self falso

Ya hemos señalado la fragilidad que tiene para Winnicott el self del niño recién nacido. Desde su punto de vista, el ser humano nace como un conjunto desorganizado de impulsos, instintos, capacidades perceptuales y motrices que, conforme progresa el desarrollo, se van integrando hasta lograr una imagen unificada de sí y del mundo externo.]

El papel de la madre es proveer al bebé de un yo auxiliar que le permita integrar sus sensaciones corporales, los estímulos ambientales y sus nascentes capacidades motrices. La madre protege con su propio sostén el débil núcleo del self infantil.]

Winnicott llama "núcleo del ser verdadero" a lo que "...emana de la vida de que están dotados los tejidos del cuerpo y de la acción de las funciones corporales, incluyendo la del corazón y la respiración. Se halla estrechamente ligado a la idea de proceso primario y al principio, en esencia, no es reactivo a los estímulos externos." (1960b, pág. 179).

En esta definición se incluyen elementos puramente fisiológicos (funciones corporales tales como la respiratoria o la cardíaca) y elementos que corresponden a un alto nivel de inferencia metapsicológica (como lo es el concepto de proceso primario, propuesto por Freud). Además hay otra idea: el núcleo sobre el que se construye el

¹ El término inglés *self* se puede traducir al español de varias maneras. Se ha utilizado la denominación "sí-mismo" para referirse a él. En la edición en español de las obras de Winnicott se tradujo este término como "ser". Por ello así será consignado en las citas. En lo que respecta a nuestro texto, empleamos indistintamente las palabras "sí-mismo" y el vocablo inglés *self*.

self no es, al comienzo de la vida, reactivo a estímulos externos. Winnicott se hace eco en esta definición de los postulados del narcisismo primario.

¿Qué sucede cuando la madre no provee la protección necesaria al frágil yo del recién nacido? El niño percibirá esta falla ambiental como una amenaza a su continuidad existencial, la que a su vez provocará en la criatura la vivencia subjetiva de que todas sus percepciones y actividades motrices son sólo una respuesta ante el peligro al que se ve expuesto. Ya no puede sentir sus movimientos o los estímulos externos como ensayos de autonomía de su yo inmaduro, sino que los vive como provocados desde un mundo amenazante. Poco a poco, recurre a reemplazar la protección que le falta por una "fabricada" por él. Todo sucede como si se fuera rodeando de una cáscara a expensas de la cual crece y se desarrolla el *self* del sujeto. Dice: "Entonces el 'individuo' se desarrolla a modo de extensión de la cáscara más que del núcleo, y a modo de extensión del medio atacante. Lo que queda del núcleo se oculta y es difícil de encontrar incluso en el más profundo de los análisis... El ser verdadero permanece escondido y lo que tenemos que afrontar clínicamente es el complejo *ser falso* cuya misión estriba en ocultar el ser verdadero" (1950, págs. 291-292).

Por el contrario, cuando el medio ambiente brinda al pequeño la protección y sostén necesarios, la "cáscara" con que nace y que explica su narcisismo primario va, poco a poco, diluyéndose, permitiendo así una entrega a la experiencia de la vida interna y externa.

En su artículo "Deformación del ego en términos de un ser verdadero y falso" (1960b), Winnicott se refiere al papel de la madre en la constitución de un *self* falso. Dice: "La madre 'buena' es la que responde a la omnipotencia del pequeño y en cierto modo le da sentido. Esto lo hace repetidamente. El ser verdadero empieza a cobrar vida a través de la fuerza que la madre, al cumplir las expresiones de omnipotencia infantil, da al débil ego del niño" (pág. 175).

"La madre que 'no es buena' es incapaz de cumplir la omnipotencia del pequeño, por lo que repetidamente deja de responder al gesto del mismo; en su lugar coloca su propio gesto, cuyo sentido depende de la sumisión o acatamiento del mismo por parte del niño. Esta sumisión constituye la primera fase del ser falso y es propia de la incapacidad materna para interpretar las necesidades del pequeño" (*ibid.*, págs. 175-176).

² Paineira (1979) utiliza estas nociones para el tratamiento de pacientes esquizoides, combinándolas con ideas de Margaret Mahler.

Si bien el primer sentido que Winnicott le dio al falso *self* estaba relacionado con la psicopatología, gradualmente este punto de vista fue cambiando.

Al principio consideró el falso *self* como una formación presente sólo en los pacientes graves, provocado por una falla en los cuidados maternos. Existiría un sometimiento del ser verdadero al gesto de la madre; tiempo después Winnicott propuso una graduación de matices, en la que el falso *self* estaría siempre presente, aunque con distintos niveles de implicación patológica.

En los casos más próximos a la salud, el ser falso actúa como una defensa del verdadero, a quien protege sin reemplazar. En los casos más graves, el ser falso reemplaza al real y el individuo (así como los que lo rodean) creen reconocer el núcleo de la persona, cuando en realidad sólo conocen la "cáscara" con que se rodeó. Hay, por último, un cierto grado de existencia del falso *self* que no sólo es compatible con la salud sino que es necesario para que ésta se dé.

Al respecto, dice nuestro autor: "En la salud: el ser falso se haya representado por toda la organización de la actitud social cortés y bien educada por un 'no llevar el corazón en la mano', pudiéramos decir. Se ha producido un aumento de la capacidad del individuo para renunciar a la omnipotencia y al proceso primario en general, ganando así un lugar en la sociedad que jamás puede conseguirse ni mantenerse mediante el ser verdadero a solas" (1960b, pág. 173).

A continuación, veremos un ejemplo en el que se aplican estos conceptos. "El mejor ejemplo que puedo darles es el de una señora de mediana edad que tenía un ser falso muy eficaz, pero que durante toda la vida había experimentado la sensación de no haber empezado a existir y de que constantemente había estado buscando un medio de llegar a su ser verdadero. Esta señora todavía se halla sometida a análisis, después de muchos años. En la primera fase de análisis exploratorio (que duró dos o tres años), comprobé que estaba tratando lo que ella había dado en llamar su 'ser custodio'. Este 'ser custodio' había hecho lo siguiente:

- 1.- Encontrar el psicoanálisis.
- 2.- Venir a probar el análisis para, mediante esta complicada estratagema, comprobar si el análisis era digno.
- 3.- Traer la paciente para que la analizase.
- 4.- Paulatinamente, después de tres o más años, pasarle su función al analista (éste fue el momento de profundidad de la regresión, existiendo durante unas semanas un grado elevadísimo de dependencia con respecto al analista).
- 5.- Rondar a la paciente, reanudando a veces la custodia cuando el

analista fallaba (por estar enfermo, de vacaciones, etc.)..." (ibid., págs. 171-172).

El falso *self*, en especial cuando se encuentra en el extremo más patológico de la escala, se acompaña generalmente de una sensación subjetiva de vacío, futilidad e irrealdad. Como se ha constituido a expensas del núcleo auténtico del ser, obliga a éste a renunciar a sus impulsos (que constituyen su esencia) en pos de una "exitosa" adaptación.

Más adelante estudiaremos la aplicación que tienen estos conceptos en la psicopatología y en la práctica psicoanalíticas.

3. Fenómenos y objetos transicionales

Estos conceptos surgieron de las agudas observaciones que realizó Winnicott sobre la conducta de los niños pequeños.

Es habitual ver que los bebés se llevan a la boca el pulgar o el puño con el objeto de estimular la zona oral. Este gesto no tiene, según muchos autores, como único objetivo obtener placer por la estimulación directa. Otro de sus efectos consiste en lograr la discriminación entre lo que forma parte del propio cuerpo y lo que no lo constituye.

Meses más tarde el mismo niño puede haberse vuelto "aficionado" a determinado juguete u objeto: un osito de trapo, una manta, un ovillo de lana.

Winnicott postuló que entre ambos fenómenos hay una relación. Los objetos a los que nos referimos constituyen la "primera posesión no-yo" del niño y, como tales, son una especie de puente tendido entre el mundo interno del pequeño y su mundo externo. Precisamente por su carácter de intermediación los llamó "fenómenos y objetos transicionales".

Los objetos transicionales pueden ser entendidos desde diversos puntos de vista; en un primer momento Winnicott les otorgó esencialmente un papel maduracional, más tarde fue ampliando el uso del concepto.

El artículo donde estudia más exhaustivamente los objetos transicionales y el primero en que los describe, fue presentado como una conferencia ante la Sociedad Psicoanalítica Británica en 1951. Allí estudia el alcance del concepto, a la vez que brinda algunos ejemplos clínicos muy ilustrativos.

En términos generales, podríamos decir que el concepto de objeto o fenómeno transicional recibe tres usos diferentes: uno de tipo

evolutivo (etapa del desarrollo), otro vinculado con las ansiedades de separación y las defensas contra ellas (un nivel defensivo), define por último, un espacio dentro de la mente del individuo. Todos estos puntos de vista relacionan la idea de objeto transicional con la salud mental. Winnicott propone, además, que en determinadas condiciones el fenómeno u objeto transicional puede tener una evolución patológica e incluso asociarse específicamente a ciertas condiciones anormales.

El objeto transicional parece jugar un importante papel en el proceso de maduración del niño. Al ser algo que no está definitivamente adentro ni definitivamente afuera del bebé, le serviría para poder experimentar con estas situaciones y para ir demarcando sus propios límites mentales en relación con lo interno y lo externo. Cuando el niño manipula el osito o la mantita adquiere sensaciones que le sirven para establecer sus límites corporales.

El recién nacido vive en un estado de dependencia absoluta respecto de su madre. La dirección del desarrollo en condiciones ambientales favorables lleva gradualmente al logro de la independencia y a una creciente diferenciación entre lo interno y lo externo. El objeto transicional está ubicado en una zona intermedia, en la que el niño se ejercita en la experimentación con objetos que, aunque están afuera, él siente como partes de sí mismo. ¿Cómo se construye el objeto transicional?

Para explicarlo, Winnicott se remonta al primer vínculo del niño con el mundo externo, la relación con el pecho materno. Citemos al autor: "La madre coloca el pecho real justo allí donde el pequeño se halla dispuesto a crear, y lo hace en el momento apropiado" (1951, pág. 326). Esto produce en el niño una ilusión de omnipotencia, el pecho es vivenciado como una parte de su propio cuerpo. Una vez lograda esta omnipotencia ilusoria, la madre debe, idealmente, ir desilusionando al niño poco a poco. La meta de este segundo paso es lograr que el bebé adquiera la noción de que el pecho es una "posesión", en el sentido de un objeto, pero que no es él ("me pertenece pero no soy yo").

El objeto transicional ocupa un lugar que Winnicott llama de la ilusión. A diferencia del pecho, que no está disponible constantemente, el objeto transicional es conservado por el niño. Es él quien gradúa la distancia entre ambos. Cuando siente que no lo necesita lo deja a un lado y, por el contrario, cuando precisa de él, lo reclama. Las madres, en general, respetan intuitivamente el apego de sus hijos a los objetos transicionales. No hay madre sensible que no

recuerde haber llevado el osito de trapo de su niño cuando salieron de viaje o que no se lo haya dado si el niño debía dormir por una noche fuera de la casa.

El osito de trapo tiene un rol en la elaboración de los sentimientos de pérdida frente a la separación con la madre. Este es un segundo sentido con el que Winnicott conceptualiza el objeto transicional. Dice al respecto: "...puede surgir alguna cosa o fenómeno - tal vez un ovillo de lana en una esquina de la manta o del edredón, o una palabra, o una tonadilla, o algún amaneramiento - que se haga de vital importancia para el pequeño a la hora de acostarse y que sea una defensa contra la angustia, especialmente la de tipo depresivo" (*ibid.*, págs. 316-317).

Como estos objetos "representan" a la madre, es decir al objeto libidinal, es esencial que ella sea vivenciada como un objeto bueno. Cuando en el interior del niño el objeto materno está dañado, es poco probable que aquél recurra de manera constante a un fenómeno transicional. Así es posible ver cómo, cuando la madre se ausenta por un tiempo prolongado, en general disminuye el apego al objeto transicional. Todos hemos observado múltiples ejemplos que podrían ser considerados como expresión de objetos y vínculos transicionales. Winnicott sintetiza las características que considera comunes a dichos objetos:

- El niño afirma una serie de derechos sobre el objeto que son respetados por los adultos.
- El objeto es afectuosamente acunado y excitadamente amado y mutilado.
- No debe cambiar a menos que el niño así lo desee.
- Debe sobrevivir al amor, al odio y de ser el caso, a la agresión pura.
- Al niño debe parecerle que da calor, se mueve, tiene textura o que hace o posee alguna cualidad que le da realidad propia.
- Si bien para nosotros procede del exterior, desde el punto de vista del pequeño esto no resulta tan obvio. Para él, sin embargo, está claro que no procede del interior, es decir que no es una alucinación.

De estas características hay una que quisiéramos destacar: la que se refiere a la necesidad de que el objeto sobreviva a la agresión. Este rasgo es de gran importancia, ya que la única forma en que el niño podrá neutralizar su agresión y darle posteriormente un fin constructivo será a través de notar que ésta no destruye a los objetos, tanto externos como internos. En la medida que el objeto transicional no resulta dañado irreversiblemente por los impulsos agresivos del niño, el objeto interno que va construyendo se hace más

fuerte y aumenta la capacidad de neutralizar la agresión en la criatura.

Una vez que la manipulación del objeto transicional permitió al niño instaurar en su interior un objeto bueno suficientemente indemne, sigue un paso importante: es menester alejarse del objeto transicional. Esto se produce a través de la diversificación de fenómenos y objetos transicionales. En todos nosotros este proceso deja una huella: queda en la mente del individuo un espacio que, al igual que el objeto transicional, es intermedio entre lo interno y lo externo. En este espacio se desarrollan muchas de las actividades creativas del hombre y también allí se produce el proceso analítico. Para dar un ejemplo, un cuadro o una pieza musical no es para el artista una parte de sí mismo, con todos los atributos que eso implicaría. Pero tampoco está por completo fuera de él. Ocupa un lugar ambiguo, de tal forma que "representa" al mundo interno para el exterior y, en cierto sentido, "representa" a la realidad para sí mismo.

Nuestro autor se refiere de la siguiente manera a esta última aplicación del concepto de objeto transicional: "Esta zona intermedia de experiencia, indisputada en lo que hace a su pertenencia a la realidad interior o exterior (compartida), constituye la mayor parte de la experiencia del pequeño y es retenida a lo largo de toda la vida dentro de las intensas experiencias propias del arte, la religión y el vivir imaginativo, así como de la labor científica creadora" (*ibid.*, pág. 330).

El objeto transicional es susceptible de tener una evolución patológica. Según el autor hay tres cuadros en los que adquiere especial importancia: el fetichismo, la adicción y el robo.

El objeto adictivo, el fetiche o lo robado constituirían sustitutos del primitivo objeto transicional. Winnicott lo refiere de la siguiente manera: "Puede plantearse la adicción en términos de regresión a la fase precoz en que los fenómenos transicionales no son disputados. Puede describirse el fetichismo en términos de la persistencia de un objeto específico o de un tipo de objeto que data de la experiencia infantil dentro del campo transicional, enlazada con la delusión de un falo materno. La pseudología fantástica y el robo pueden ser descritos en términos de la necesidad inconsciente y apremiante que siente el individuo de tender un puente sobre la laguna de la continuidad de la experiencia con respecto al objeto transicional" (*ibid.*).

Para el caso del desarrollo patológico Winnicott cree, como en otros problemas, que son las fallas maternas, inconstancia en el vínculo, dificultad emocional en el contacto y otros, las que terminan por alterar el desenlace normal del objeto transicional.

4. Desarrollo emocional primitivo

Los lectores que hayan consultado algunos de los capítulos de este libro podrán advertir la frecuencia con que los autores psicoanalíticos, luego de describir ciertos fenómenos que consideran novedosos dentro del psicoanálisis elaboran, a partir de ellos, una teoría del desarrollo.

La que estableció Winnicott fue, en sus comienzos, muy influida por los postulados kleinianos. Recordemos su proximidad a Melanie Klein en los primeros años de su formación analítica.

Una exposición bastante completa de la teoría del desarrollo winnicottiana es la que publicó en 1945 bajo el título "Desarrollo emocional primitivo". Plantea una hipótesis acerca de la evolución que sigue el ser humano desde su nacimiento hasta los primeros años de vida.

Propone que la maduración emocional se da en tres etapas sucesivas: la de integración y personalización, la de adaptación a la realidad y la de preinquietud o crueldad primitiva.

1 La integración y la personalización: Winnicott afirma que el bebé nace en un estado de no integración. Los núcleos del yo están dispersos y para el bebé estos núcleos están incluidos en una unidad que forma él con el medio ambiente. Es un período de dependencia absoluta.

A La meta de esta etapa es la integración de los núcleos del yo y la personalización, es decir, adquirir la sensación de que el cuerpo aloja al verdadero self. Explicaremos ambos procesos por separado, aunque es importante recordar que se dan simultáneamente y están íntimamente relacionados.

1A La integración se logra a partir de dos series de experiencias: **I** Por un lado, tienen especial importancia los cuidados de la madre, quien "recoge los pedacitos" del yo y le permite al niño sentirse integrado dentro de ella. Ya vimos al principio de este capítulo el papel de las técnicas de cuidados infantiles, las que Winnicott dice que consisten fundamentalmente en proteger del frío, bañar, acunar, nombrar, etc.

II Por otro lado, hay un tipo de experiencias que podrían agruparse bajo el término de instintivas, "que tienden a reunir la personalidad en un todo partiendo desde dentro" (1945, pág. 210).

Desde el nacimiento el bebé pasa por periodos fugaces de integración, que se van haciendo progresivamente más duraderos. Llega

por fin un momento en que la criatura ha logrado, merced a las experiencias que acabamos de describir, reunir los núcleos de su yo y adquirir la noción de que él es distinto del medio que lo rodea. Este es un momento "peligroso" para el bebé, ya que el exterior puede ser sentido como perseguidor y amenazante. Nuevamente es la madre quien asume la responsabilidad de protegerlo del mundo externo. Las amenazas quedan neutralizadas, dentro del desarrollo sano normal, por la existencia del cuidado amoroso por parte de la madre.

El lector advertirá que el yo frágilmente integrado, si no se cumplen los objetivos anteriores, será presa fácil de la desintegración. Para Winnicott el quiebre psicótico constituiría una regresión a esta temprana fase del desarrollo.

2 El otro objetivo del desarrollo emocional en este período es la personalización, definida por Winnicott como "el sentimiento de que la persona de uno se halla en el cuerpo propio" (*ibid.*, pág. 210). Si bien el autor no hace una referencia explícita al hecho, parece evidente que la idea de personalización surgió de la despersonalización observada en los psicóticos, que constituiría una regresión a estados tempranos del desarrollo.

En torno a esta idea Winnicott construye una teoría en la cual propone que el desarrollo normal llevaría al logro de un esquema corporal, lo llama unidad psiquesoma. Al igual que la integración, la personalización requiere una feliz confluencia de cuidados maternos satisfactorios y experiencias instintivas.

Si bien las alteraciones de la integración y la personalización se expresan principalmente en los trastornos psicóticos, Winnicott aclara que todos los adultos y niños normales pueden pasar por estados de despersonalización o no integración en condiciones de fatiga extrema o al enfrentarse con problemas emocionales muy intensos.

Hay, finalmente, una experiencia relacionada con la no integración. Se trata de la disociación. En ésta, persiste un cierto grado de separación entre distintos fragmentos del yo. Sucede, para mencionar sólo algunos ejemplos de esta situación, en el sonambulismo o en la dificultad para percibir que la madre que frustra es la misma que proporciona las experiencias placenteras.

2A Adaptación a la realidad: A medida que el niño progresa tenemos a un ser humano con un yo relativamente integrado y con la sensación de que el núcleo del sí-mismo habita en su propio cuerpo. El y el mundo son dos cosas separadas.

El siguiente paso es llegar a una relación óptima con ese mundo externo. En otras palabras, lo que debe lograr es la adaptación a la realidad.

Recordemos que si el bebé tiene hambre puede alucinar algo que sacie su apetito. La madre ofrece en ese momento su pecho, un objeto real. Esto constituye el primer aporte que hace la madre para aproximar al pequeño a la objetividad. "El bebé alucina algo que puede ser atacado y entonces la madre le acerca el pezón real. El niño siente que eso es lo que acaba de alucinar y ...sus ideas se ven enriquecidas por los datos reales de la vista, el tacto, el olfato... De esta manera el pequeño empieza a construirse la capacidad para evocar lo que está realmente a su disposición" (*ibid.*, pág. 213).

La madre tiene un importante rol, proveer a la criatura de los elementos de la realidad con que construir la imagen psíquica del mundo externo. Para Winnicott, la fantasía precede a la objetividad y el enriquecimiento de aquélla con aspectos de la realidad depende de la ilusión creada por la madre. Todo reposa en el vínculo temprano del niño con su madre. Evidentemente el acoplamiento entre la alucinación infantil y los elementos de la realidad aportados por la madre nunca podrá ser perfecto. Sin embargo, el infante puede vivirlo como casi óptimo gracias a una parte de la personalidad del niño que se ocupa de "llenar" el vacío entre la alucinación y la realidad. A este aspecto de la psique humana Winnicott lo bautizó "la mente". Se refiere a ella de la siguiente forma: "La actividad mental del pequeño hace que un medio ambiente *suficiente* se transforme en uno perfecto, es decir convierte el fallo de adaptación en un éxito. Lo que libera a la madre de la necesidad de ser casi perfecta es la comprensión del pequeño" (1949, pág. 334).

Este concepto adquiere importancia en determinados cuadros patológicos. Si el medio ambiente no proporciona los cuidados que el psiquesoma siente como elementales, la mente se ve obligada a una sobreactividad en la que "...el pensamiento del individuo empieza a asumir el control y a organizar el cuidado del psiquesoma, mientras que en condiciones saludables esto es función del medio. En estado de salud, la mente no usurpa la función del medio, sino que posibilita una comprensión, y eventual aprovechamiento, de su fallo relativo" (*ibid.*, pág. 335).

El lector podrá advertir la relación que tiene el concepto de "mente" con el de "falso *self*"; lamentablemente las similitudes y relaciones entre ambos conceptos no fueron discutidas por Winnicott.

3 → **La crueldad primitiva (fase de preinquietud):** Hasta aquí la criatura ha logrado no sólo sentirse a sí misma como un ser distinto a los demás y ante el medio, sino también adaptarse en cierta medida a la realidad a través de absorber pautas objetivas de ella que modifican sus fantasías. A través de su "mente" aprendió a "llenar" el vacío que existe entre el sostenimiento adecuado y el perfecto y esto mejoró sustancialmente sus relaciones con el mundo.

El último paso que debe dar es integrar en un todo las distintas imágenes que tiene de su madre y del mundo. Winnicott piensa que el niño pequeño tiene una cuota innata de agresividad que se expresa en ciertas conductas autodestructivas (chuparse el pulgar hasta hacerse daño, meterse el puño en la boca aún a riesgo de ahogarse, etc.). El bebé repliega su odio sobre sí mismo para preservar el objeto externo. Pero esta maniobra no resulta suficiente. En su fantasía, la madre puede resultar intensamente dañada.

Por otro lado la madre es, además del objeto que recibe en ocasiones la agresión de la criatura, quien lo cuida y protege. Podríamos dibujar un circuito en el cual el bebé expresa rabia y recibe amor, con lo cual se confirma no sólo que la madre ha sobrevivido sino que es un ser separado del niño. La criatura adquiere la noción de que sus propios impulsos no son tan dañinos y puede, poco a poco, aceptar la responsabilidad que tiene sobre ellos.

Simultáneamente, la madre cuidadora y la madre agredida van acercándose en la mente del pequeño, quien adquiere así la capacidad de preocuparse por su bienestar como objeto total. Esto constituye el gran logro de lo que Winnicott identifica como la última de las etapas del desarrollo emocional primitivo, aunque, aclaremos, es altamente frecuente que no se complete en la infancia.

Para quien conozca la teoría kleiniana de la posición depresiva (Melanie Klein, 1935, 1940) es evidente su influencia sobre Winnicott. En efecto, la idea de la fase de preinquietud está relacionada directamente con ella, tal como lo reconoce Winnicott. El problema terminológico implicado al cambiar el nombre de "depresiva" por el de "inquietud" es explicado por Winnicott a partir de la connotación patológica que tiene el término "depresivo". Cree que es incorrecta dicha denominación ya que esta fase, al igual que la posición descrita por Melanie Klein, son componentes normales del desarrollo emocional.

¿Qué sucede si la madre no puede proporcionar los cuidados necesarios en esta etapa? En la fantasía del niño, sus impulsos agresivos habrían triunfado con fatales consecuencias. Si el único reaseguro para la criatura de que sus fantasías no son mortales es la supervi-

vencia del objeto, que se expresa en la reiteración de los cuidados y la entrega de amor, es fácil advertir la repercusión que podría tener en ella las fallas en esta provisión de afecto. En primera instancia, en la mente del niño persistirá la separación de la madre dañada y la madre amorosa. En segundo lugar, la incapacidad para sentir inquietud se expresará en una imposibilidad para realizar actividades reparatorias. Mencionemos que la reparación está en la base de todas las actividades creativas. Así, una perturbación en la maduración emocional dará como resultado un individuo temeroso de sus propios impulsos, sin capacidad creativa alguna y, probablemente, con un mundo externo e interno fragmentados, como reflejo de la imagen materna escindida que guarda en su interior.

Antes de terminar esta parte del capítulo destinada a describir la teoría winnicottiana del desarrollo, quisiéramos insistir en algunas de sus características relevantes.

La maduración emocional del ser humano transcurre desde una etapa de dependencia absoluta a una de independencia. En el recorrido que el niño debe realizar para alcanzar independencia la madre juega un papel fundamental, no sólo para la conservación de la vida en términos biológicos, lo que parece obvio, sino para la construcción de un mundo interno suficientemente integrado.

La agresión del niño no responde únicamente a una vocación destructiva innata. Por el contrario, expresa una esperanza, la de ser amado y comprendido. El niño manifiesta a través de sus impulsos, en ocasiones agresivos, la necesidad de que le respondan: "no me has destruido", "te amo y te protegeré". Este es el puente que tiende la criatura hacia el mundo externo. De la respuesta de la madre depende que pueda lograr una adecuada adaptación a la realidad. Tómese en cuenta, por lo tanto, que la realidad es al mismo tiempo la que frustra y la que gratifica.

El éxito en este desarrollo se evidencia por la capacidad para la creatividad y la fantasía, que serían esenciales en el adulto sano.

Ideas sobre la comunicación

Dijimos que para Winnicott el ser verdadero es el núcleo de la personalidad y permanece oculto. El falso *self* lo encubre en mayor o menor grado, conformando así cuadros de distinto matiz de salud o enfermedad. Se considera normal un cierto nivel de "encubrimiento" del ser verdadero, es lo que hemos descripto, a través de las palabras del propio Winnicott, como "un no llevar el corazón en la mano".

Winnicott aplica estas ideas al considerar los resortes de la co-

municación interpersonal. Tradicionalmente, se considera la ausencia de comunicación en el análisis como una resistencia. Desde esta perspectiva, la negativa del paciente a comunicar sus sentimientos o ideas es perjudicial para el tratamiento. Para vencer este obstáculo se han propuesto diversos instrumentos técnicos.

Winnicott no lo entiende así. Puesto que en el verdadero *self* persiste, en la medida que le sea permitido, un cierto nivel de claudicación, la no comunicación podría tener una meta saludable: la de preservar al ser verdadero. Propone que la falta de comunicación con el mundo externo puede corresponderse con un aumento de la comunicación con el mundo interno y que ésta, a su vez, ayuda a instaurar un sentimiento de realidad. La tesis central de su teoría sería la siguiente: "...en la personalidad sana o normal hay un núcleo que equivale al ser verdadero de la personalidad escindida, y sugiero que este núcleo nunca se comunica con el mundo de los objetos percibidos, y que la persona, el individuo, sabe que no debe establecerse comunicación con dicho núcleo ni dejar que la realidad externa influya en él" (1963c, pág. 227); más adelante agrega: "...una de las bases importantes para el desarrollo del ego reside en el campo de la comunicación individual con los fenómenos subjetivos, comunicación que por sí sola proporciona el sentimiento de realidad" (*ibid.*, pág. 228).

El sujeto que no se comunica momentáneamente con el mundo externo probablemente lo esté haciendo con sus objetos internos o subjetivos, como los llama Winnicott, y esta comunicación le brinda un sentimiento de realidad que no siempre se logra por la comunicación con los objetos externos.

Propone distinguir dos formas de incomunicación: la simple y la activa. En la primera, la persona estaría momentáneamente relacionada con sus objetos internos. Puede ser considerada un descanso del que se retorna fácilmente a la comunicación. La incomunicación activa, por el contrario, podría significar un estado más cercano a la patología. El replegamiento del individuo hacia sus objetos subjetivos podría significar una necesidad exacerbada de contacto con el ser verdadero, en búsqueda de lograr un sentimiento de realidad del que carece. Podríamos preguntarnos en este caso hasta qué punto son sentidas como reales las expresiones del mundo externo. El caso extremo de este tipo de incomunicación se ejemplifica con el autismo. El enfermo tiene una comunicación intensa y absorbente con su propio mundo y los seres humanos que le rodean no suscitan en él respuestas comunicacionales.

El replegamiento, utilizado en una forma saludable y tolerado

por el terapeuta, puede tener una capacidad curativa por sí mismo. "La preservación del aislamiento personal forma parte de la búsqueda de identidad y de la instauración de una técnica personal de comunicación que no conduzca a la violación del ser central" (*ibid.*, pág. 230).

El antecedente evolutivo de esta adquisición se halla en cierto momento de la vida infantil en la que el niño logra estar a solas en presencia de otro, sin sentir angustia y sin por ello abandonar la identificación con el objeto. Sería como un estado intermedio en el cual "estoy con el otro, pero sin por ello dejar de ser yo mismo".³

¿Qué es lo que enferma?

Winnicott dedicó gran parte de sus esfuerzos por entender el origen de las enfermedades mentales, a dos entidades psicopatológicas: la psicosis y la tendencia antisocial o psicopatía. Además escribió un trabajo referido a los trastornos de carácter y a su tratamiento analítico, donde los vincula con la tendencia antisocial.

En lo que respecta a las neurosis típicas, Winnicott respetó en primera instancia la teoría clásica, que las explica a través del complejo de Edipo.

Los principales elementos patógenos en la teoría winnicottiana son, como vimos, los fallos ambientales y sus consecuencias sobre la estructuración del *self* verdadero y falso. A continuación discutiremos cómo se aplican estas ideas a cada uno de los cuadros clínicos que mencionamos antes.

En el tránsito de la dependencia absoluta a la independencia el bebé necesita un medio que le brinde la posibilidad de expresar libremente sus impulsos y le proporcione un sentimiento de continuidad existencial. Si la madre tiene éxito en esta vital misión, el niño podrá integrar los núcleos del yo que en un principio están dispersos. Cualquier falla en la provisión materna es sentida como un ataque al núcleo del *self*.

³ Quisiéramos mencionar que para Winnicott los orígenes del individuo se sitúan en el noveno mes de gestación. Dice textualmente: "...para afirmar tal cosa me fundo en que hay grandes diferencias que son observables si el bebé es prematuro o posmaturo. Sugiero que al finalizar los nueve meses de gestación el pequeño está maduro para el desarrollo emocional, y que, si el bebé es posmaturo habrá alcanzado esta fase en el vientre de su madre, por lo que uno tiene que tener necesariamente en cuenta sus sentimientos antes y durante el nacimiento. Por lo contrario, el niño prematuro no experimentará demasiadas cosas de importancia vital hasta que haya alcanzado la edad en que debería haber nacido" (1945, págs. 207-208).

al núcleo del self.

El resultado de ataques sostenidos es que el núcleo de la personalidad del bebé, representado por sus impulsos instintivos, se defiende del ambiente hostil. *Forma una coraza a través de someter una parte de su persona al medio atacante; esta coraza es el falso self.* Los ataques impiden, además, la integración de los núcleos del yo. La precariedad de este estado hace que cualquier estímulo proveniente del exterior sea sentido como una amenaza. La salida que le queda al sujeto es el replegamiento patológico y su única posibilidad de comunicación es con el ser verdadero escondido en su interior. Toda otra relación es sentida como irreal.

Refiriéndose a la psicosis, Winnicott dice: "Etiológicamente, esta enfermedad está ligada con el fallo ambiental, es decir con el fallo del medio ambiente en su misión de posibilitar los procesos de maduración en la fase de doble dependencia (dependencia absoluta)" (1963b, pág. 275).

La ubicación temporal de este proceso no está muy clara en la obra de Winnicott. "Como ya he dicho, en el transcurso de estas primeras semanas, meses, años, el pequeño adquiere también la capacidad para relacionarse con los objetos, habita en su propio cuerpo y en las funciones del mismo, y experimenta un sentimiento de 'Yo soy' mostrándose dispuesto a enfrentarse a cuanto le espere."

Estos avances en el individuo, que se apoyan en los procesos de maduración, son lo que constituye la salud mental. Es a la antítesis o reverso de estos mismos procesos a lo que debemos dirigirnos para comprender los trastornos de la personalidad de tipo esquizoide" (1963a, pág. 293).

Otro trastorno en el que la falla ambiental tiene un importante papel patógeno es la psicopatía o tendencia antisocial.

En su artículo "Clasificación: ¿Existe una aportación psicoanalítica a la clasificación psiquiátrica?" Winnicott escribe: "Es preciso, en primer lugar, tratar de definir la palabra 'psicopatía'. En este contexto yo la utilizo - creo que justificadamente - para describir una afección adulta consistente en una delincuencia no curada. El delincuente es un niño, o una niña, antisocial que no ha sido curado... hay lógica en la actitud implícita de que 'el medio ambiente me debe algo' que adopta el psicópata, el delincuente y el niño antisocial... Mi tesis principal en este sentido es que, en esencia, la inadaptación y demás derivados de este tipo de trastorno consisten en una inadaptación originaria del medio ambiente al niño que se produjo en una fase no lo bastante precoz para dar origen a una psicosis. El énfasis recae en el fallo ambiental, y la patología, por tanto, está principalmente en el medio ambiente, y sólo de manera secundaria en la

reacción del niño" (1959, págs. 161-162).

Por otra parte la tendencia antisocial, lejos de expresar impulsos agresivos y vengativos respecto del medio ambiente frustrante, es una manifestación de esperanza de que éste note el fallo y lo corrija. La psicopatía sería un estado más avanzado del trastorno, en el cual se produce un endurecimiento de las defensas ante el "desengaño total".

Un tercer desorden mental que mereció el interés de Winnicott fue la caracteropatía. En su trabajo "Psicoterapia de los trastornos de carácter", define a éstos como "...una deformación de la estructura del ego, si bien la integración no desaparece por ello" y más adelante aclara: "...el valor del término corresponde específicamente a una descripción de la deformación de la personalidad que se produce cuando el niño necesita dar cabida a cierto grado de tendencia antisocial" (1963d, pág. 248).

Este punto de vista constituye el origen de una propuesta terapéutica específica diseñada en tres pasos sucesivos. En primer lugar, el analista debe ayudar al paciente a disecar el conflicto hasta llegar a la enfermedad que se encuentra oculta tras la caracteropatía (en este caso la meta es descubrir la tendencia antisocial). Un segundo paso constituye el enfrentamiento con la tendencia antisocial y, una vez analizada suficientemente, será posible el último escaño del tratamiento, en el cual el análisis deberá tener en cuenta la deformación del ego y la explotación a que éste se ha sometido durante sus intentos de autocuración (*ibid.*, pág. 253).

5. Aspectos técnicos. El sostenimiento en el setting analítico y la regresión

Winnicott cree que el encuadre analítico reúne las condiciones necesarias para favorecer la regresión del paciente. Si bien esta idea está presente en muchos de los modelos psicoanalíticos, en Winnicott asume características especiales.

En primer lugar, debemos aclarar que para nuestro autor la regresión es un retorno a etapas muy primarias del desarrollo emocional del ser humano en las que el mundo no era otra cosa que la relación diádica con la madre. En este sentido el espacio de la sesión brindaría una segunda oportunidad para el desarrollo, otorgando esta vez el sostenimiento "suficientemente bueno" que el individuo no tuvo en su infancia".

¿Qué es lo que confiere al encuadre analítico esta capacidad? Mencionaremos algunos de los factores involucrados: el analista brinda una presencia predecible, está allí, se preocupa por el paciente, expresa su amor y su odio (más adelante discutiremos este punto), no juzga moralmente el material que le es presentado, ni a la persona que se lo presenta. En síntesis: "El marco del análisis reproduce las técnicas de maternalización más tempranas. Invita a la regresión por su confiabilidad" (1954, pág. 388).

Pero si bien ésta es una condición ambiental que predispone a la regresión, debe identificarse un factor de índole endopsíquica necesario para que se produzca.

Winnicott propone que cuando los fallos ambientales tempranos son repetitivos existe un congelamiento de la situación de fracaso. Todo sucede como si en el momento en que éste tuvo lugar, se dio una acumulación de ideas, recuerdos y sentimientos relacionados. Esta acumulación expresaría la esperanza de que en el futuro pueda surgir una oportunidad, es decir un medio favorable, para que todas esas sensaciones sean expresadas y superadas.

El análisis vendría, entonces, a llenar un vacío en la historia del sujeto que quedó a la espera de ser colmado. "En la teoría del desarrollo del ser humano hay que incluir la idea de que es normal y sano que el individuo pueda defender el self contra un fracaso específico del medio mediante la congelación de la situación de fracaso. Junto a esto va la suposición inconciente (susceptible de convertirse en una esperanza conciente) de que más adelante habrá oportunidad para una experiencia renovada en la cual la situación de fracaso pueda ser descongelada y reexperimentada, con el individuo en estado de regresión, dentro de un medio que esté realizando una adaptación adecuada. Afirmo, pues, la teoría de que la regresión es parte de un proceso curativo..." (*ibid.*, pág. 381).

Resumamos lo dicho hasta aquí. El análisis, en la medida que reúne las condiciones de un holding (sostén), promueve la regresión a una situación de fracaso ambiental vivida en la primera infancia. El proceso analítico, que inaugura esta situación, retoma el desarrollo del sujeto en aquel punto donde quedó congelado a consecuencia de la falla en el medio ambiente.

De estas ideas puede deducirse que Winnicott concibe la regresión como una vuelta al estado de dependencia del niño, en el que los instintos están desorganizados y su mundo está constituido básicamente, por la relación diádica con la madre.

Las pulsiones fálicas, genitales y anales tienen un papel secundario en el proceso. Podríamos incluso afirmar que ni siquiera se jerar-

quizan las pulsiones orales, ya que el vínculo diádico madre-hijo no está concebido como ámbito en el que jueguen un papel principal dichas pulsiones, sino como un tipo de relación en la que ambos protagonistas participan de manera total. Es la cualidad emocional del contacto lo que importa y en el análisis lo que se revive en la regresión es precisamente esto.

La regresión en un marco adecuado tiene un efecto curativo por sí misma. El proceso analítico puede ser resumido en la siguiente secuencia:

- 1) La provisión de un marco que inspira confianza.
- 2) La regresión del paciente a un estado de dependencia con la debida sensación de riesgo que ello comporta.
- 3) El paciente tiene un nuevo sentido de ser y el ser hasta ahora oculto se rinde ante un yo total. Se produce una nueva progresión de los procesos individuales que se habían detenido.
- 4) Hay una descongelación de la situación de fracaso ambiental (que es sentida en la transferencia como fracaso del analista).
- 5) Partiendo de una posición de mayor fuerza del yo, el paciente se permite sentir ira con el fracaso ambiental precoz, vivenciado y expresado en el presente.
- 6) Retorno de la regresión a la dependencia, siguiendo un progreso ordenado hacia la independencia.
- 7) Las necesidades y deseos instintivos se hacen realizables con auténtica vitalidad y vigor.

El paciente en regresión no recuerda su pasado sino que lo vive. El está en el pasado. El estado regresivo favorece las actuaciones. Esto debe ser comprendido por el analista como parte de la regresión y no como complicaciones del tratamiento. En las actuaciones el analizado podrá revivir el fracaso ambiental y la externalización de su enojo permitirá la superación de aquél y el logro de un nuevo sentimiento del self.

¿Cómo se puede asegurar que un paciente está en regresión? Winnicott cree que en la regresión el vínculo entre analista y analizado es diádico. No hay, como sucede en las neurosis de transferencia, un tercer sujeto, ausente de la sesión. El marco del análisis representa a la madre con su técnica de maternación y el paciente es un niño pequeño.

No todos reaccionan de igual manera ante la regresión. La cuota de dolor que ésta implica depende de la estabilidad emocional del sujeto. Cuanto más sana es la estructura psíquica del individuo, más angustia despierta el retorno a la dependencia absoluta. Por el contrario, en las personas con graves perturbaciones psiquiátricas, el

dolor proviene de los sentimientos de futilidad e irrealdad que lo embargan más que de la relación dependiente.

Este tipo particular de vínculo exige del analista una actitud muy especial, dado que lo que se espera de él es que actúe con una sensibilidad extrema. Tal como la madre en los primeros meses de vida, deberá poder percibir lo que el paciente necesita. Muchas veces es necesario guardar absoluto silencio o mantenerse totalmente inmóvil para no obstaculizar el proceso que se desarrolla en el interior del paciente. Otras, especialmente cuando se produce la actuación, la verbalización del fenómeno tranquiliza al paciente y le permite recordar el fracaso ambiental original que dio lugar a la enfermedad. En resumen, el psicoanalista debe lograr una identificación tal con el paciente que le permita intuir qué es lo que éste necesita de él, tal como se espera que lo haga una madre "suficientemente buena".

La condición de ser "suficientemente bueno" no excluye la posibilidad de fracasos en la adaptación. Pero éstos, lejos de ser considerados como factores negativos, jugarán un importante papel en la curación. Las fallas, verbalizadas por el paciente y admitidas por el analista, permitirán que la ira original salga a la luz. Sólo después de que esto haya sucedido, será posible alcanzar un nuevo sentimiento de realidad.

La transferencia en la teoría de Winnicott

Resulta fácil comprender que, dado el papel que se le adjudica a la regresión en la teoría de Winnicott, deberán surgir modificaciones en el concepto de transferencia.

El paciente regresivo transita por un estado de desintegración del yo que le dificulta estructurar una neurosis de transferencia. En cambio, como ya lo mencionamos, revive como si fueran actuales relaciones emocionales primitivas. En estas condiciones el marco psicoanalítico adquiere más importancia que la interpretación, ya que cumple la función de holding. Los éxitos que el analista tenga en adaptarse a las necesidades regresivas del paciente, son aprovechadas por éste para retomar el desarrollo emocional que había quedado interrumpido. Los fracasos, como ya dijimos, sirven para recuperar la vivencia de las malas experiencias originales.

La explicitación del odio contratransferencial

Hay pacientes en los que el sentimiento predomina ambivalencia. Las fallas en la adaptación ambiental

fueron tan grandes que no conciben la posibilidad real de ser amados.]

[En estos casos, Winnicott propone que "si el paciente busca odio objetivo o justificado, debe ser capaz de encontrarlo, de lo contrario es imposible que se crea capaz de encontrar amor objetivo" (1947, pág. 273).

En otras palabras, lo que sugiere es que el analista explicita al paciente los sentimientos adversos que suscita. Si no lo hace, tampoco será posible que el paciente crea en el amor que el analista siente por él. La expresión "odio objetivo" se refiere a los sentimientos que el analizado despierta en su terapeuta, ya depurados de los conflictos neuróticos que éste puede estar depositando en el vínculo.]

El rol de la familia y las instituciones en el tratamiento de los enfermos mentales

Dedicaremos una última descripción al papel que Winnicott asigna a la familia durante el tratamiento de sus pacientes.

[La jerarquización del rol de la madre en la superación de los conflictos infantiles lo llevó a optar, en algunos casos, por brindar un soporte terapéutico a la madre de los pequeños para que fueran éstas las que rectificaran sobre la marcha sus errores y ayudaran a sus hijos a superar sus problemas. En ocasiones, las entrevistas con la madre tenían lugar con varios meses de diferencia y los encuentros con el niño eran ocasionales. El único fin que éstos perseguían era ajustar el diagnóstico o detectar los conflictos que la madre era incapaz de percibir.]

Por último, quisiéramos agregar que Winnicott amplió el concepto de *holding* a la relación que sostiene una determinada institución con quienes son acogidos por ella. Así, los hospitales psiquiátricos o las instituciones para reclusión de individuos con tendencias antisociales (en particular las destinadas a adolescentes) pueden cumplir un cierto rol en la recuperación de sus internados. Si la institución acepta jugar un papel de *maternación* "suficientemente buena" es posible, según nuestro autor, lograr una mejoría o incluso la *recuperación total*.]

Bibliografía Básica

Winnicott, D.W. (1945) "Desarrollo emocional primitivo". En *Escritos de pediatría y psicoanálisis*. Barcelona: Laia. 1979. *Collected Papers. Trough Paediatrics to Psycho-Analysis*. London: Tavistock.

tock. 1958.

- (1951) "Objetos y fenómenos transicionales. Estudio de la primera posesión 'No-Yo' ". En *Escritos de pediatría y psicoanálisis*. Barcelona: Laia. 1979. *Collected Papers. Trough Paediatrics to Psycho-Analysis*. London: Tavistock. 1958.
- (1954) "Aspectos metapsicológicos y clínicos de la regresión dentro del marco psicoanalítico". En *Escritos de pediatría y psicoanálisis*. Barcelona: Laia. 1979. *Collected Papers. Trough Paediatrics to Psycho-Analysis*. London: Tavistock. 1958.
- (1960a) "La teoría de la relación paterno-filial". En *El proceso de maduración en el niño*. Barcelona: Laia. 1975. *The Maturation Processes and the Facilitating Environment*. London: The Hogarth Press. 1965.
- (1960b) "Deformación del ego en términos de un ser verdadero y falso". En *El proceso de maduración en el niño*. Barcelona: Laia. 1975. *The Maturation Processes and the Facilitating Environment*. London: The Hogarth Press. 1965.

12. WINNICOTT. DISCUSION Y COMENTARIOS

La obra escrita de Donald Winnicott no es particularmente extensa, comprende unos cuatro libros. Pero hay muchas ideas originales que merecen ser discutidas. Didácticamente proponemos diferenciarlas según traten de problemas sobre el desarrollo infantil, las teorías psicopatológicas que de allí se deducen, consideraciones metapsicológicas, observaciones aisladas y, finalmente, propuestas técnicas.

Hacia los años cuarenta, cuando Winnicott empezó su producción como psicoanalista, el panorama de nuestra disciplina mostraba, por un lado, la gran construcción freudiana ya terminada y, al mismo tiempo, el surgimiento de un nuevo enfoque sobre las relaciones de objeto a través de la obra de Melanie Klein y de Fairbairn. La adhesión entusiasta al psicoanálisis y también a Freud, no permitió advertir a quienes iniciaban el estudio de las relaciones de objeto, los profundos cambios conceptuales que estaban introduciendo dentro del psicoanálisis.

Actualmente resultan más claras las diferencias entre un psicoanalista clásico y otro que, como Winnicott, no lo es. Basta leer sus artículos para que esto se ponga en evidencia. Es diferente el lenguaje teórico, el tipo de preocupaciones y los hechos clínicos en que se concentran cada uno de ellos. Para Freud la base de los conflictos humanos se debe a la lucha entre las pulsiones y la cultura, entre el ello, el yo y el superyó. Winnicott, por su parte, piensa que los problemas psicológicos se inician en el vínculo del recién nacido con la madre. Casi todo depende de si ésta es adecuada o no, si puede acercarse a su bebé, sostenerlo, personalizarlo y ayudarlo a madurar. La conflictiva edípica, aunque no queda rechazada, es secundaria en gran medida a la forma en que evolucionan los vínculos diádicos. La base de la estabilidad mental depende de las expe-

riencias iniciales con la madre y, sobre todo, del estado emocional que ella tenga. Winnicott es de la idea de que sus hallazgos son pertinentes para patologías especiales y que la teoría freudiana, basada en el complejo de Edipo o en el de castración, sigue siendo completamente válida para las neurosis. Creemos, sin embargo, que estas afirmaciones no reflejan todo el cambio que él introduce en la teoría. También Bianchedi, E. T.; Gioia, T. y Rabih, M. (1983) opinan que Winnicott estaría junto a Bowlby y Fairbairn pues "Los tres han descentrado el complejo de Edipo de su rol fundamental en la estructuración de la personalidad y de su posición como 'complejo nodular de las neurosis'" (pág. 191).

En Freud, la terapia debe lograr que una representación reprimida encuentre su expresión en la conciencia; el psicoanalista es un detective que está a la caza de una verdad oculta; si la logra revelar, el síntoma desaparece. En su camino encuentra las resistencias de las instancias psíquicas pero esos obstáculos no impedirán finalmente que la verdad se abra paso. Cuando la representación se enlaza al afecto, el nudo conflictivo se desata. Pensemos por un momento qué nos propone Winnicott. El sujeto tiene escondido su verdadero *self* y el analista intenta salir a su encuentro. Debe proporcionar el marco emocional de confianza y sostén adecuado para que el paciente se anime a traerlo, luego habrá que corregir las experiencias defectuosas. Ofrecerle al paciente lo que no tuvo: una madre suficientemente buena. Aquí el analista crea procesos que nunca existieron, capacidades y funciones psicológicas, dota a su paciente de estructuras ausentes. Si Freud es arqueólogo, Winnicott será constructor.

Justamente el mérito y también las dificultades de los conceptos de Winnicott se deben a la originalidad de su búsqueda. Su teorización, que nos parece confusa por momentos, posee sin embargo algunos puntos de partida que son claros y hay una metapsicología implícita. El no se preocupó en escribir acerca de cómo fue construida su teoría. Hizo sus observaciones sin buscar coherencia ni reflexionar exhaustivamente en un nivel metapsicológico sobre los problemas que le interesaron.

El estilo de Freud es distinto al de Winnicott. Formado en el laboratorio y la neurología clínica, debe presentar por necesidad metodológica tanto el instrumento con que hace las observaciones (sus teorías presupuestas) como las conclusiones que saca. Winnicott procede al revés, da por sentado el método y va directamente a las conclusiones. El lector debe saber que si el microscopio de Freud, por decirlo así, está formado por sus teorías de las pulsiones, la sesión analítica y el bagaje conceptual neurofisiológico que utili-

za, el de Winnicott es el hospital pediátrico, la entrevista a bebés junto con sus madres y el análisis infantil. No piensa como un biólogo ni reflexiona sobre la sociedad humana o las pulsiones. Lo hace tomando como punto de partida las madres que observa o los niños con los que tiene contacto.

Hay, nos parece, dos mentalidades diferentes, dos puntos de partida alternativos. Uno, el de Freud, escucha a la paciente histérica quejarse de una parálisis. El otro, el de Winnicott, recibe a una madre que trae a su niño porque no quiere comer o padece somatizaciones. Es distinto pensar la patología con la mente de un antropólogo, de un biólogo, de un neurofisiólogo experimental, en fin, que con la de un pediatra durante los años cuarenta en el medio londinense, donde Melanie Klein comenzaba su producción tan brillante y revolucionaria, en que el tema de las relaciones interpersonales se introducía velozmente dentro del psicoanálisis y donde el papel de la madre era cada vez más tenido en cuenta. Al estudiar el primer vínculo emocional con la madre en términos de experiencias sensoriales, afectivas y de constitución del psiquismo, se pasa de una postura edípica a una bipersonal, del falo al pecho, del triángulo a la relación con la madre.

Si antes de las relaciones de objeto la atención estaba puesta en los mecanismos de defensa y la problemática edípica, Winnicott, junto a Melanie Klein, piensa en una línea evolutiva en que lo arcaico define lo por venir.

Sutherland (1980, pág. 835) tiene razón en que Winnicott puso poesía e imaginación creadora en su obra. Es una virtud que va unida a la soltura para crear y ambas cosas reflejan aspectos del trabajo clínico de nuestro autor.

Seguramente muchos de los lectores coincidirán con nosotros en que las aportaciones más importantes que hizo Winnicott son sus ideas sobre el objeto transicional, la diferencia entre *self* verdadero y falso, la noción de sostén o *holding* y las muchas observaciones sobre el desarrollo emocional primitivo.

Sus propuestas técnicas, especialmente el concepto de regresión y el papel que le asigna al analista en el tratamiento, pueden ser cuestionadas. La metapsicología implícita que Winnicott utiliza descarta la pulsión de muerte y considera que la agresión humana es producto de una falla ambiental. Con estas ideas, expone una versión sobre las relaciones de objeto en que el papel del ambiente es decisivo. Es el caso opuesto a Melanie Klein. Esta autora estudia las fantasías libidinales y sádicas del bebé partiendo de las pulsiones de vida y de muerte que propuso Freud; para ella quedan en segundo

plano las cualidades reales de la madre.

Con su idea de las series complementarias, Freud entendió la psicopatología como el lugar de encuentro entre lo interno y lo externo, la pulsión y los hechos de la vida cotidiana. Pareciera que Klein por un lado, y Winnicott por otro, estudiaron de manera divergente cada uno de los aspectos de estas series complementarias.

Winnicott cree que hay tres espacios psíquicos. El interno, el externo y el transicional. Este último es, a su vez, la consecuencia de aceptar una etapa de narcisismo primario y de fusión inicial entre el niño y la madre. El bebé está cerrado sobre sí mismo y la realidad va a golpear las puertas de esta supuesta vesícula narcisista para imponer limitaciones y frustraciones. Como parte de la maduración se acepta gradualmente que existe una realidad externa. El espacio transicional es una zona intermedia que va del narcisismo primario al juicio de realidad. Al comienzo hay objetos que no son internos ni externos, luego vendrá la delimitación entre ambos. Mientras que la fusión inicial es aceptada tanto por Winnicott como por Mahler y Hartmann, otros piensan que el recién nacido tiene desde el comienzo un equipamiento etológico con el que puede delimitar las áreas interna y externa. Lichtenberg (1979, 1981), por ejemplo, se apoya en algunos trabajos realizados por neonatólogos para argumentar que existe una diferenciación inicial entre sujeto y objeto. Más allá del problema evolutivo, el analista cuando está frente a su paciente debe definir si la confusión sujeto-objeto que tiene su enfermo proviene de una falla en el desarrollo (una función que no se estableció) o es producto de una intención de su mente. Busquemos un ejemplo para entender ambas ideas. Si el paciente habla como su analista o no diferencia lo que son los conocimientos y capacidades de uno y otro, ¿cuánto hay en esta actitud de intención narcisista, producto de la rivalidad y cuánto de fallas evolutivas? El analista que piensa como Winnicott puede no reconocer la intención hostil o narcisista y terminar siendo ingenuo.

El objeto transicional (la mantita, el oso de peluche, etc.) significa para Winnicott tres cosas:

- a) es una primera posesión yo-no yo;
- b) sirve para enfrentar la ansiedad de separación con la madre;
- c) es parte del espacio de la ilusión, una zona de la mente.

Como se ve, la teorización de Winnicott tiene en cuenta enfoques que son diferentes entre sí. En un caso, se trata del proceso evolutivo que permitirá desarrollar el juicio de realidad; en otro, es una defensa particular ante la ansiedad de separación o es parte de la relación de objeto. El tercer aspecto tiene que ver con la metapsi-

cológia de la organización mental. Es una topología: estudio de los espacios y de los conjuntos que hay en ellos.

Winnicott definió, con su idea de objeto transicional, un hecho clínico que es fácilmente observable. No hay duda que el objeto transicional calma las ansiedades de separación del niño pequeño. Le permite dormir en ausencia de la madre, lo tranquiliza y lo capacita para separarse de ella con menos angustia.

La afirmación de que el objeto transicional es una primera posesión yo-no yo (el primer objeto que no es ni parte de la realidad interna ni de la externa) no puede ser dilucidada por el método de observación que usa Winnicott. El riesgo de injertar en el bebé nuestros propios puntos de vista es muy grande. Se trata de una hipótesis que queda en suspenso hasta que se invente una manera más precisa de comprobarla o rechazarla. Igual pasa con la propuesta de Melanie Klein de que el bebé tiene una posición esquizo-paranoide o depresiva y una rica vida de fantasía; son construcciones provisionarias que nos pueden servir para pensar los problemas.

La idea de que la transferencia repite el pasado y lo que observamos en nuestros pacientes nos dice qué sucedió en la mente del bebé es más que cuestionable. La transferencia sí reproduce el mundo interno del paciente (Meltzer, 1981); por nuestra parte agregamos que quizá su conexión con el realismo arcaico es una suposición que habría que demostrar por otros métodos, para no hacer una profecía autocumplida o, como a veces se dice en broma, una sociedad de respeto mutuo entre las teorías y los hechos.

Es interesante analizar las fantasías que poseen los niños o nuestros pacientes adultos sobre los objetos transicionales para ampliar la comprensión que tenemos de estos fenómenos. ¿Cómo diferenciar un objeto transicional de otro masturbatorio? Supongamos el caso del paciente que parece más interesado en la textura del almohadón del diván que en el contacto con el analista. Las cosas no son sencillas. Hay autores que homologan al analista con un objeto transicional (Goldstein, R., 1980, pág. 177). Winnicott considera que la psicopatía, las adicciones y el fetichismo son trastornos en el proceso de utilización del objeto transicional. Nos parece que hay una exageración (benevolente) en esa comprensión y que se omiten los fenómenos del narcisismo, la perversión, el complejo de Edipo y la castración. Winnicott fue sin duda un hombre bondadoso y apasionado a la vez. Por momentos nos parece que desea ver al ser humano mejor de lo que realmente es.

Isaacs Elmhirst (1980) piensa que la noción de objeto transicional, aunque interesante y útil, tiene algunos problemas:

a) el objeto transicional termina siendo más importante que la madre;
 b) no cree que haya suficiente evidencia clínica para aceptar que un individuo no puede desarrollarse normalmente si no ha tenido realmente un objeto transicional; y finalmente,
 c) piensa que hay una desproporción entre el grado de interés despertado por el tema y el enunciado que hizo el propio Winnicott. Ella solo admitiría la importancia dada al objeto transicional si se lo toma como una parte del proceso de internalización de un objeto bueno. Esta autora considera que la utilidad del estudio del objeto transicional se asocia a una comprensión de la evolución mental donde el individuo aprende a distinguir entre la madre y sí mismo, abandono-control, animado e inanimado, delirio-fantasia, hecho e ignorancia, realidad interna y externa, ecuación simbólica-internalización.

Romano (1980) hace tres comentarios interesantes sobre la idea de objeto transicional. Cree, en primer lugar, que la teorización es confusa porque Winnicott no logró desprenderse de la idea kleiniana de objeto. En segundo lugar, piensa que la propia teorización es ambigua; finalmente, entiende que Winnicott no formuló una metapsicología.

A continuación revisaremos algunas de las ideas de Winnicott sobre el vínculo temprano, inicial, entre la madre y su bebé. Nos parece de la máxima importancia que éste es considerado en términos humanos y no sólo biológicos. "El desarrollo emocional primitivo" (1945) describe de una manera excelente el papel de la madre en integrar al niño. Ella, según las propias palabras del autor, debe "juntar los pedacitos y permitirle al niño sentirse dentro de ella". La madre, al nombrar al hijo, lo unifica. Esta problemática coincide en buena parte con la que desarrollará Lacan años más tarde (1949) y también Melanie Klein (1946). Kohut (1971, 1977), por otra parte, debe muchas de sus ideas a Winnicott. Por ejemplo, el papel de la función especular de la madre (darle amor y sostener la omnipotencia infantil para luego desilusionarlo gradualmente).

Winnicott da importancia al aspecto madurativo. A medida que el ser humano progresa, aumentan sus capacidades de integración. No objetaríamos esta manera de pensar, pero sí nos gustaría aclarar que se trata de uno de los enfoques posibles; también se puede considerar a la escisión como un proceso defensivo (Melanie Klein, 1946) y hasta ofensivo, o sea que lleva la intención de atacar al objeto quitándole partes buenas (Etchegoyen, 1986).

Winnicott jerarquiza el concepto de disociación y lo utiliza en

un sentido muy amplio (ejemplos: guerra y paz, la vida en las ciudades, etc.); piensa que opera durante toda la vida. La disociación no tiene una motivación en sí misma, está producida por la falta de integración de la personalidad. En el mismo trabajo de 1945 describe el momento de ilusión: la unión de un estado de alucinación con una experiencia de contacto con el pecho. En ese momento, según palabras de Winnicott, "el pequeño es capaz de sentir que eso, el pezón, es lo que acaba de alucinar" (pág. 213).

El momento de ilusión es un antecedente del concepto de objeto transicional. Puede operar como objeto de la realidad y también como alucinación. La idea de ilusión nos parece muy adecuada pues une la emoción, la representación y el contacto con la realidad.

Los escritos de Winnicott son sugestivos y dan elementos para pensar muchos problemas aunque no siempre son claros. Sin embargo, luego de leer cualquiera de sus trabajos nos sentimos estimulados para crear. Fue uno de los primeros autores que jerarquizó el papel de la madre en el funcionamiento mental del niño. Consideró que ella interviene no sólo como una pantalla para las proyecciones del bebé sino también como una constructora activa de su espacio mental. Al otorgarle un papel tan importante, sugiere que el objeto externo es mucho más que un modulador de las proyecciones del niño. Participa de una verdadera unidad con su hijo, ayuda a formar su mente y a que este proceso salga bien. Al darle amor, le suministra una suerte de "energía vital" que lo hace progresar y madurar.

El trabajo "La teoría de la relación paterno filial" (1960a) propone que el sostenimiento o *holding* es esencial para el desarrollo emocional del pequeño. A ello le agrega la convivencia de la madre y el niño y el aspecto triádico, convivencia del padre, la madre y la criatura. El *holding* "... comprende en especial el hecho físico de sostener la criatura en brazos y que constituye una forma de amar" (pág. 56). Para Winnicott, el destino de cada sujeto humano se juega durante los primeros años de vida, según el resultado del vínculo con la madre. Es el ambiente el que debe adaptarse adecuadamente al niño para formar su verdadero *self*. El pequeño se desarrolla por su propia potencialidad. Si la madre se adecua de una manera suficientemente buena, no interfiere en el desarrollo del niño. Las perturbaciones que surgen cuando la adaptación no es buena son sentidas por el bebé como un ataque a su persona.

No es la madre, de todas maneras, quien moldea totalmente al niño; éste tiene una autonomía personal dada por sus capacidades innatas para el desarrollo. La madre asegura el marco para que el proceso continúe. Forma un ambiente "neutro" que es el sostén del

progreso para su hijo. .

Winnicott no explica, sin embargo, qué condiciones específicas son necesarias para que se produzca el fracaso ambiental y el falso *self* se hipertrofie o se organice patológicamente. Los factores quedan insinuados, pero distintos observadores adjudicarían diferentes causas a los mismos procesos. Es una característica de la manera de escribir de Winnicott que los conceptos nunca quedan cerrados sino que se insinúan para que el lector los complete. Para algunos esto será un mérito, otros lo verán como falta de rigurosidad. Nosotros estaríamos más inclinados, en algunos casos, a considerar esta última posición.

Es importante subrayar la extensión progresiva que va dando Winnicott al término de falso *self*. Primero lo considera un componente de la patología grave, psicosis especialmente, para terminar en trabajos posteriores incluyéndolo como parte de la neurosis y el carácter normal.

Esta ampliación es cuestionable pues de allí va a deducir consecuencias técnicas importantes que cambian muchos de los aspectos clásicos de la técnica psicoanalítica.

Sería importante, además, que se pudiese diferenciar el falso *self* producido por el ataque ambiental, de aquél que se origina en el narcisismo del sujeto. Podemos pensar que Winnicott estudió el falso *self* producido por una falla ambiental mientras que Melanie Klein tomó en cuenta aquél que es consecuencia de la emocionalidad interna del sujeto. Cada teoría tiene axiomas alrededor de los cuales se organiza. Winnicott cree, en ese sentido, que al salir del narcisismo primario el destino del sujeto depende del fracaso o el éxito del ambiente. No considera que los celos, el narcisismo o la envidia sean factores determinantes internos tan fuertes como los externos. Lógicamente, podría preguntársele a Winnicott si es posible pensar que un sujeto reciba adecuadamente lo que necesita y no lo pueda aprovechar. Nuestros pacientes y también nosotros mismos, preferimos subrayar las privaciones que hemos sufrido, antes que reconocer nuestros obstáculos internos para utilizar lo bueno de los objetos primarios. Con la idea de falso *self*, Winnicott razona de una manera "rousseauiana": el sujeto nace bueno, el medio lo hace malo. Tenemos que decir que a los pacientes les encanta esta teoría, muchas veces argumentan su historia personal desde esa perspectiva. Pero no nos parece del todo cierta, ya que borra la idea de responsabilidad psíquica del sujeto (Klein, 1940, 1946; Meltzer, 1967).

Otros autores también estudiaron los pacientes que Winnicott

clasifica como falso *self*, proponiendo para ellos diferentes denominaciones. Coincidimos con Morse (1972) en que el falso *self* de Winnicott es, en su esencia, lo que Balint denominó falta básica. También puede encontrarse cierta superposición con la descripción que hace Helen Deutsch de las personalidades "como si" y con los fenómenos que Bick (1964) y Meltzer (1975) estudiaron bajo el nombre de identificación adhesiva. Kohut se refiere a una problemática similar con su descripción de algunos pacientes narcisistas y de los fracasos en la constitución del *self*.

Winnicott comparte con algunos postkleinianos como Bion y Meltzer la importancia que da en sus teorizaciones a la madre real, aunque la diferencia que separa a winnicottianos y kleinianos sobre el papel de la agresión, la fantasía inconciente y la envidia es bien definida.

Etchegoyen (1986, cap. 41) discrepa con Winnicott en varios aspectos. Sus comentarios son sumamente elaborados y merecen una lectura atenta. Intentaremos resumir sus puntos de vista, con los cuales estamos totalmente de acuerdo.

En lo teórico, él cree que se nos presentan dificultades serias si aceptamos, como lo hace Winnicott, la idea del narcisismo primario. Considera que el ambiente no tiene toda la responsabilidad en el destino psicótico del ser humano, no se pueden negar los impulsos internos, la pulsión de muerte y la conflictiva edípica.

Aunque el tan debatido problema del narcisismo primario (estado inicial de fusión sujeto-objeto) sea de difícil solución, para Etchegoyen, siguiendo a Melanie Klein y a los etólogos modernos, el bebé nace con capacidades que, aunque precarias, le permiten diferenciar los aspectos internos de otros externos. Supone, además, que el bebé tiene mucho de propio para agregar a su evolución personal. ¿Por qué responsabilizar exclusivamente a la madre del destino de su hijo? Razona ingeniosamente de la siguiente manera: aún si se acepta una situación inicial de unión indiferenciada madre-bebé, ¿por qué sólo tener en cuenta una de las partes? La experiencia clínica le hace pensar a Etchegoyen que emociones tales como los celos, la envidia y el narcisismo atacan aspectos buenos de la madre y en el análisis, por la transferencia, los del analista. ¿Por qué aceptar que el paciente sólo revive el fracaso ambiental y no también los aciertos de los padres? Todo esto resulta convincente cuando pensamos en las experiencias con pacientes que algunas veces, desgraciadamente, nos hacen fracasar en nuestros mejores intentos por ayudarlos.

Etchegoyen está muy de acuerdo con algunas ideas de Winnicott, como el concepto de *holding* y la diferencia que este autor hace

entre no integración y disociación.

En el aspecto técnico, no acepta la idea de que la regresión sea terapéutica en sí misma y producida por el encuadre. Piensa que la trae el paciente y es lo que constituye su enfermedad. Cita a Macalpine (1950) cuando esta autora dice que los aspectos bondadosos del análisis no tendrían por qué provocar regresión, sólo los frustrantes serían responsables de esa situación. Para Etchegoyen es sumamente ambigua la formulación de Winnicott de que no debemos interferir con la regresión del paciente, no se entiende si se trata de quedarse callado, tocarlo o tomar algún otro tipo de medidas. Esta teoría tendría un aspecto omnipotente si se piensa que vamos a poder resolver y hacer de nuevo aquéllo que no hubo o falló en la infancia. Un analista puede dar interpretaciones y hasta crear funciones mentales, pero no puede hacer de nuevo a su paciente y ser la madre que el sujeto no tuvo; tendríamos que borrar los hechos reales y poner otros en su lugar. Tampoco cree que deba expresarse el odio que el analista sintió hacia el paciente y que éste sea objetivo, pues siempre lo sentimos desde nuestra subjetividad. Más aún: como analistas tratamos de entender los sentimientos del paciente y si nos enojamos contra él, será una reacción humana muy comprensible, pero no el objetivo de nuestra tarea, que es la de interpretar.

Para concluir, queremos volver a resaltar que Winnicott abrió nuevas perspectivas acerca del conflicto psíquico, la importancia de la madre real en el desarrollo del niño, la influencia decisiva de las ansiedades de separación y la jerarquía de los vínculos diádicos junto a los edípicos.